

**UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE  
MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE ENFERMERIA EN  
CENTRO QUIRÚRGICO**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OBTENER  
EL TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL DE  
DE ENFERMERIA EN CENTRO QUIRÚRGICO**

**ANALGESIA EN EL PARTO EUTÓCICO DE UNA MUJER  
INTERNADA EN UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE  
ATENCIÓN EN BAGUA GRANDE, AMAZONAS, PERÚ:  
REPORTE DE UN CASO CLÍNICO**

**Autores: Lic. Violeta Fernández Piedra  
Lic. Adriano Fernández Rafael  
Lic. Marleny Chavez Montenegro**

**Asesora: Dra. Sonia Tejada Muñoz**

**Registro:**

**CHACHAPOYAS - PERÚ**

**2025**

**Analgesia en el parto eutócico de una mujer internada en un Hospital de segundo nivel de atención en Bagua Grande, Amazonas, Perú: Reporte de un caso clínico**

**Analgesia in the eutocic delivery of a woman admitted to a secondary care hospital in Bagua Grande, Amazonas, Peru: A clinical case report**

Violeta Fernández Piedra, Adriano Fernández Rafael, Marleny Chavez Montenegro

**RESUMEN:**

El presente trabajo tuvo como finalidad describir el manejo de la analgesia en una gestante atendida durante un parto eutócico en un hospital nivel II de Bagua Grande, en la región Amazonas del Perú, a través del análisis de un caso clínico. La paciente, cursando el tercer trimestre de embarazo, expresó su deseo de recibir analgesia durante el trabajo de parto vaginal, el cual se desarrolló sin complicaciones. Para la valoración integral se utilizaron los patrones funcionales de Marjory Gordon, permitiendo identificar necesidades y problemas de cuidado relevantes. Con base en ello, se formularon diagnósticos de enfermería según la clasificación NANDA y se establecieron intervenciones NIC y resultados NOC orientados al bienestar de la paciente. Los cuidados se enfocaron principalmente en aspectos relacionados con el confort, el afrontamiento frente al estrés y la percepción/cognición. Finalmente, se evidenció que el manejo del dolor incluyó tanto medidas farmacológicas como estrategias no farmacológicas, buscando brindar una atención más humana, segura y centrada en las necesidades de la gestante, favoreciendo además una experiencia de parto positiva y respetuosa.

**Palabras clave:** parto eutócico, analgesia, cuidados de enfermería, hospital.

**ABSTRACT:**

The purpose of this study was to describe the management of analgesia in a pregnant woman undergoing eutocic labor at a Level II hospital in Bagua Grande, Amazonas, Peru, through the analysis of a clinical case. The patient, who was in her third trimester of pregnancy, expressed her desire to receive analgesia during vaginal labor, which progressed without complications. For the comprehensive assessment, the functional health patterns proposed by Marjory Gordon were applied, allowing the identification of relevant care needs and problems. Based on this assessment, nursing diagnoses were formulated according to the NANDA classification, and NIC interventions and NOC outcomes were established to promote the patient's well-being. Nursing care mainly focused on comfort, coping and stress tolerance, and perception/cognition. In conclusion, pain management included both pharmacological and non-pharmacological measures aimed at providing humane, safe, and patient-centered care, while also promoting a positive and respectful childbirth experience.

**Keywords:** eutocic labor, analgesia, nursing care, hospital.

## INTRODUCCIÓN:

El manejo del dolor en el parto eutócico representa un desafío clínico relevante dentro de la atención obstétrica contemporánea, especialmente en contextos donde coexisten prácticas de medicalización excesiva y limitaciones en el acceso a recursos especializados. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la tasa de cesáreas no debe superar el 15% del total de nacimientos, ya que cifras mayores no evidencian mejoras en los resultados maternos ni neonatales. No obstante, en países de América Latina, como Brasil y República Dominicana, esta tasa supera el 50%, lo cual refleja una tendencia preocupante hacia la intervención quirúrgica innecesaria y una disminución proporcional de los partos eutócicos (World Health Organization, 2025).

En el Perú, esta situación también se manifiesta, según el Ministerio de Salud (MINSA), en el año 2022 se registran 459,613 nacimientos, de los cuales el 39% corresponde a cesáreas, superando ampliamente el estándar recomendado (Rodríguez Bernal, 2022). En contraste, en la región Amazonas, la proporción de cesáreas se sitúa en 20.5%, lo que se acerca más a lo sugerido por la OMS y sugiere una mayor prevalencia de partos vaginales, probablemente asociados a factores de acceso, ruralidad y condiciones estructurales de los servicios de salud (*Instituto Nacional de Estadística e Informatica*, 2022)

El parto eutócico, a pesar de ser un proceso fisiológico y natural, implica una experiencia de dolor que puede impactar negativamente en el bienestar físico y emocional de la gestante si no se gestiona adecuadamente. Por ello, el abordaje del dolor se convierte en un componente clave dentro de la atención humanizada. Entre las estrategias disponibles, la analgesia epidural destaca como una de las más efectivas. Estudios recientes, como el de Barroga et al. (2023), demuestran que el uso de analgesia epidural controlada por la paciente con sufentanilo y ropivacaína permite una reducción significativa del dolor, manteniendo el bienestar materno-fetal (Barroga et al., 2023).

A partir de esta problemática, surge la pregunta: ¿De qué manera el manejo de la analgesia, desde una perspectiva de cuidado integral de enfermería, impacta en la experiencia del parto eutócico de una paciente internada en un centro de segundo nivel en Bagua Grande, Amazonas? El reporte de caso, tiene como propósito: describir el manejo de la analgesia durante el parto eutócico en una paciente internada en un Hospital de segundo nivel en la

ciudad de Bagua Grande, Amazonas en Perú mediante el estudio de un caso real.

El desarrollo del análisis se realiza a través de una metodología cualitativa de tipo descriptivo, enfocada en el estudio de caso y guiada por el Proceso del Cuidado Enfermero (PCE), bajo los lineamientos de las taxonomías NANDA-I, NOC y NIC. Asimismo, se consideran elementos psicosociales, éticos y clínicos, a fin de promover un cuidado integral, segura y centrada en las necesidades reales de la mujer. Esta reflexión busca fortalecer las competencias profesionales para una toma de decisiones informada y empática durante el trabajo de parto eutócico.

Este informe de caso clínico se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y cualitativo, enfocado en el cuidado brindado a una paciente embarazada durante un parto eutócico en un hospital de la ciudad de Bagua Grande, en la región Amazonas - Perú. Dicho caso fue seleccionado teniendo en cuenta su relevancia para evidenciar el rol del cuidado de enfermería en la gestión de la analgesia y la humanización del parto en entornos hospitalarios con recursos escasos.

Este caso fue seleccionado ya que simboliza una situación frecuente en servicios de emergencia obstétrica, en los que el equipo de enfermería debe proceder con criterio clínico, agilidad y sensibilidad para proporcionar un cuidado integral y seguro. El manejo del parto eutócico en un contexto de segundo nivel requiere habilidades particulares de la especialidad en urgencias y emergencias, tales como la valoración adecuada del dolor, la aplicación de tácticas analgésicas eficientes y la adopción de decisiones enfocadas en la persona. Asimismo, examinar este caso posibilita potenciar la habilidad de resolución del profesional de enfermería en escenarios donde se necesita una respuesta inmediata y humanizada frente a sucesos clínicos urgentes.

## **PRESENTACIÓN DEL CASO:**

Se presentó el caso clínico de una paciente identificada con las iniciales G.D.C., de sexo femenino, de 36 años de edad, segundigesta y con 39 semanas de gestación. Durante la evaluación obstétrica se registraron los siguientes datos: fecha de última menstruación (FUR) 08-06-2024, fecha probable de parto (FPP) 15-03-2025, altura uterina de 35 cm,

presión arterial de 103/68 mmHg, frecuencia cardíaca de 89 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto y saturación de oxígeno de 99 %. La paciente cursaba un trabajo de parto eutócico, manteniéndose condiciones maternas y fetales estables durante el proceso.

Este caso permitió resaltar la importancia de brindar un abordaje integral y humanizado en el manejo del dolor durante el trabajo de parto, especialmente en el contexto de atención hospitalaria de segundo nivel en la ciudad de Bagua Grande. Para la valoración de enfermería se emplearon los patrones funcionales de Marjory Gordon, organizando la información obtenida según las necesidades y respuestas identificadas en la paciente.

## **VALORACIÓN**

Percepción y mantenimiento de la salud, la paciente femenina de 36 años, conviviente, con nivel de instrucción secundaria y ocupación de ama de casa, procedente de Bagua Grande, Amazonas. Ingresa al servicio de emergencia obstétrica del hospital I El Buen Samaritano el 11 de marzo del 2025 con diagnóstico de gestante de 39 semanas por FUR. Se encuentra en aparente estado general regular, consciente, lúcida, afebril, con piel y mucosas ligeramente deshidratadas. Refiere contracciones uterinas esporádicas, niega pérdida de líquido amniótico o sangrado vaginal. Fue valorada por ginecología y anestesiología para manejo del dolor. Se evidencia ansiedad ante el proceso de parto, pero mantiene adecuada cooperación y vínculo con su acompañante.

En el patrón nutricional-metabólico, la paciente presenta un peso de 59.5 kg, talla 1.54 m e IMC de 23.5 kg/m<sup>2</sup>. Mucosa oral hidratada, piel normo térmica, sin signos de desnutrición evidente. Exámenes de laboratorio dentro de rangos normales: leucocitos 13.8 k/μL, hemoglobina 12.7 g/dL, plaquetas 223,000. Bioquímica con glucosa 73 mg/dL, urea 21 mg/dL, creatinina 0.66 mg/dL. Orina de aspecto turbio, sin proteinuria ni leucocituria significativa. Células epiteliales en cantidad regular y bacterias escasas. Se observa cabello negro, quebradizo, en higiene regular, uñas cortas.

Respecto al patrón de eliminación, refiere micción sin dificultad. El examen de orina no revela alteraciones relevantes. No se evidencia retención urinaria ni alteraciones intestinales.

En cuanto a la actividad–ejercicio, presenta signos vitales dentro de rangos aceptables: PA inicial 110/70 mmHg (en evolución a 90/50 mmHg), FC 82 lpm, FR 20–23 rpm, temperatura 36 °C, y SpO<sub>2</sub> 96%. Se moviliza con dificultad debido a las contracciones uterinas. A la auscultación, se evidencia buen pasaje de murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Llenado capilar menor a 2 segundos, sin cianosis ni disnea. Extremidades inferiores con debilidad leve, columna simétrica.

En el patrón sueño–descanso, la paciente refiere sueño disminuido debido al dolor y ansiedad. No usa medicación para inducir el sueño.

A nivel cognitivo–perceptivo, se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona. Pupilas isocóricas y reactivas a la luz. Presenta ansiedad, pero responde adecuadamente a estímulos y mantiene contacto verbal coherente.

En cuanto al autoconcepto, mantiene higiene personal aceptable y preocupación por su estado. Se encuentra emocionalmente comprometida con el proceso obstétrico y presenta ansiedad moderada.

Respecto a rol–relaciones, la paciente está acompañada por un familiar, con quien mantiene un vínculo afectivo positivo. Participa activamente en las decisiones sobre su atención.

En el patrón sexualidad–reproducción, se encuentra en trabajo de parto activo. Abdomen globuloso, AU 34 cm, situación longitudinal, presentación cefálica izquierda, movimientos fetales presentes, LCF 144–140 lpm. Tacto vaginal con dilatación de 4 cm, cérvix blando y posterior, altura de presentación -2, membranas ovulares íntegras, dinámica uterina 3/10 minutos (++ a +++). Bienestar fetal confirmado por monitoreo.

En adaptación–tolerancia al estrés, la paciente se muestra ansiosa, aunque sin crisis. Se moviliza con ayuda y expresa verbalmente su temor, pero acepta las indicaciones del personal de salud. Apoyo emocional presente.

No refiere manifestaciones religiosas o espirituales durante la atención. Se muestra receptiva a los procedimientos médicos y con actitud cooperativa.

## **DIAGNÓSTICO, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN:**

Las principales etiquetas diagnósticas de enfermería fueron identificadas conforme a la taxonomía de la North American Nursing Diagnosis Association, lo que permitió reconocer las respuestas humanas más relevantes de la paciente. Posteriormente, los diagnósticos se priorizaron considerando la jerarquía de necesidades propuesta por Abraham Maslow, favoreciendo un abordaje centrado en las necesidades fisiológicas y de seguridad durante el trabajo de parto.

La planificación de los cuidados se desarrolló mediante la clasificación de intervenciones de enfermería NIC, mientras que los resultados esperados se establecieron con base en la clasificación NOC, permitiendo orientar y evaluar de manera sistemática la atención brindada. A partir de la valoración y de los datos obtenidos, se identificaron los siguientes diagnósticos de enfermería prioritarios:

- ✓ **Dolor agudo (00132)** relacionado con procesos fisiológicos del parto, manifestado por verbalización del dolor y expresión facial de malestar.
- ✓ **Ansiedad (00146)** relacionada con la experiencia del parto y el miedo al dolor, manifestada por inquietud verbal y conducta de tensión.
- ✓ **Conocimientos deficientes (00126)** relacionado con técnicas de manejo no farmacológico del dolor, manifestado por solicitud de información.



☒ **Tabla 1. Plan de Cuidados de Enfermería – Diagnóstico: Dolor Agudo (00132)**

| Elemento                 | Contenido                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio NOC              | II. Salud Fisiológica                                                                                                                                                    |
| Clase NOC                | B. Sensación y percepción                                                                                                                                                |
| Resultado Esperado (NOC) | - Control del dolor (1605) - Nivel de malestar (2109)                                                                                                                    |
| Indicadores (NOC)        | - Verbalización del dolor - Escala EVA - Expresión facial                                                                                                                |
| Intervenciones (NIC)     | - Manejo del dolor (1400): administrar analgesia prescrita, evaluar nivel del dolor. - Apoyo emocional (5270): permitir acompañante, contacto verbal y visual constante. |
| Puntuación esperada      | Mantener en 2 → Lograr 4 (escala 1–5)                                                                                                                                    |

☒ **Tabla 2. Plan de Cuidados de Enfermería – Diagnóstico: Ansiedad (00146)**

| Elemento                 | Contenido                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio NOC              | I. Salud Psicológica                                                                                                                                                                  |
| Clase NOC                | A. Emociones                                                                                                                                                                          |
| Resultado Esperado (NOC) | - Nivel de ansiedad (1211) - Afrontamiento de la situación (1302)                                                                                                                     |
| Indicadores (NOC)        | - Conducta de tensión - Inquietud verbal - Tono de voz y expresión Corporal                                                                                                           |
| Intervenciones (NIC)     | - Disminución de la ansiedad (5820): explicar el proceso de parto, favorecer ambiente tranquilo. - Educación sobre el proceso del parto (5480): brindar información clara y oportuna. |
| Puntuación esperada      | Mantener en 2 → Lograr 4                                                                                                                                                              |

**☑ TABLA 3. Plan de Cuidados de Enfermería – Diagnóstico: Conocimientos Deficientes (00126)**

| Elemento                 | Contenido                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio NOC              | V. Salud del conocimiento                                                                         |
| Clase NOC                | A. Adquisición de conocimiento                                                                    |
| Resultado Esperado (NOC) | - Conocimiento: control del dolor (1808)                                                          |
| Indicadores (NOC)        | - Respuestas a la enseñanza - Participación en técnicas de manejo del dolor                       |
| Intervenciones (NIC)     | - Enseñanza: manejo del dolor (5510): enseñar respiración, posturas, uso de hidroterapia o calor. |
| Puntuación esperada      | Mantener en 2 → Lograr 4                                                                          |

### **EVALUACIÓN:**

**Durante y después de la implementación del plan de cuidados, se valoran los siguientes indicadores:**

- Reducción del nivel de dolor reportado por la paciente (EVA 3/10).
- Disminución de signos de ansiedad (respiración calmada, expresión facial relajada).
- Participación activa de la gestante en el trabajo de parto mediante técnicas aprendidas.
- Satisfacción de la paciente respecto al acompañamiento y atención recibida.

La evaluación final muestra que la paciente manifestó sentirse escuchada, acompañada y con mayor control sobre su proceso de parto, lo que refleja el éxito del cuidado centrado en la mujer y de las intervenciones propuestas.

## RESULTADOS:

Se desarrollaron tres planes de cuidado de enfermería a partir de tres diagnósticos de enfermería, desde que la paciente ingresa:

| Dominio (NANDA)                              | Clase (NANDA)     | Diagnóstico (Etiqueta NANDA)      | Resultado (NOC)                                                      | Intervención (NIC)                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. Confort</b>                           | 1. Confort físico | Dolor agudo (00132)               | - Control del dolor (1605)<br>- Nivel de malestar (2109)             | - Manejo del dolor (1400)<br>- Apoyo emocional (5270)                                |
| <b>9. Afrontamiento/Tolerancia al estrés</b> | 2. Respuestas     | d Ansiedad (00146)                | - Nivel de ansiedad (1211)<br>- Afrontamiento de la situación (1302) | - Disminución de la ansiedad (5820)<br>- Educación sobre el proceso del parto (5480) |
| <b>5. Percepción/Cognición</b>               | 4. Conocimiento   | Conocimientos deficientes (00126) | - Conocimiento: control del dolor (1808)                             | - Enseñanza: manejo del dolor (5510)                                                 |

## DISCUSIÓN:

Este caso ilustra la importancia de un enfoque integral y basado en evidencia del manejo del dolor en el parto. Los profesionales de enfermería están en la obligación y deber de realizar una valoración inicial y continua para planificar sus intervenciones. La experiencia del dolor durante el parto eutócico (parto vaginal sin problemas) es intensa y multifactorial y las opciones no farmacológicas van desde métodos no invasivos, como el apoyo continuo durante el parto, hasta técnicas como la inyección de agua estéril (Chen et al., 2024). Pese a que la analgesia epidural es la norma, se está incrementando el interés en técnicas no medicamentosas para controlar el dolor, gracias a su seguridad y menos efectos colaterales. Estos procedimientos aspiran a potenciar la experiencia de la madre y pueden ser una opción o complemento a las alternativas de medicamentos. La hidroterapia, el acompañamiento, la libertad de movimientos, la pelota suiza y las inyecciones de agua estéril son los procedimientos más comprobados para aliviar el dolor durante el parto (García & Herranz, 2023).

Se incluyeron 43 estudios con nueve intervenciones no farmacológicas. El metanálisis de redes bayesianas mostró que la acupresión (DME = -2,00, ICr del 95%: -3,09 a -0,94), la aromaterapia (DMSM = -2,01, ICrI del 95%: -3,70 a -0,35) y la terapia de masaje (DME= -1,26, ICR del 95%: -2,26 a -0,30) tuvieron efectos positivos significativos en el alivio del dolor del parto, siendo la aromaterapia la más eficaz. Los resultados también revelaron que el yoga (DME = -130,85, ICR del 95%: -212,01 a -59,32) y la acupresión (DME = - 10,14, IC del 95%: -20,24 a -0,41) fueron las intervenciones más efectivas para acortar la primera y la segunda etapa del parto, respectivamente (Huang et al., 2021).

Los hallazgos respaldan la implementación de tratamientos no medicamentosos, en particular la aromaterapia y la acupresión, para mitigar el dolor durante el parto en mujeres embarazadas de bajo riesgo. Se aconseja utilizar intervenciones no medicamentosas para gestionar el dolor durante el parto, acorde a las preferencias y valores de las mujeres que son madres. Se han logrado hallazgos prometedores respecto a estas medidas alternativas, sin embargo, es imprescindible continuar fomentando su investigación y la capacitación de enfermeras.

Sin embargo, si el dolor de parto no se alivia y el proceso no avanza y menos prospera pudiese usar analgesia farmacológica. Al respecto, existen reportes que abordan esta necesidad de las mujeres. Un estudio con ciento ochenta gestantes, nulíparas o multíparas mayores de 36 semanas de gestación después de 3 cm de dilatación cervical en parto espontáneo o inducido, realizado en el Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario Dexeus; en donde a todas las pacientes se les administró analgesia epidural (AE) según protocolo. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la efectividad de la analgesia epidural en el trabajo de parto normal frente al obstruido. Las pacientes que recibieron analgesia epidural y tuvieron trabajo de parto obstruido tienen el mismo grado de escala de calificación verbal que las pacientes que no tuvieron trabajo de parto obstruido ( $P > .05$ ) (Sánchez-Migallón et al., 2017). Otro estudio realizado en un Hospital universitario de España, afirmó que BEPI+AECP se asocia con una mayor frecuencia de partos no instrumentados y la posibilidad de partos instrumentados aumenta con IC frente a BEPI+AECP. Hay menos bloqueo del motor con BEPI+AECP que con IC+AECP. No hay diferencias en el tiempo de dilatación, expulsión o satisfacción del paciente (Rodríguez González et al., 2019).

El estudio reclutó a 200 pacientes (103 BEPI, 97 AECP). La dosis total administrada fue significativamente mayor en el grupo BEPI: grupo AECP 52,97 mg, IC 95% 45,65-60,28 mg y grupo BEPI 62,04 mg, IC 95% 55,46-68,61 mg ( $p = 0,021$ ). El grupo BEPI requirió menos bolos de recarga (valor mediano 1; rango 0-2) que el grupo CEI + AECP (valor medio 6; rango 3-9)  $p < 0,05$ . Las puntuaciones de satisfacción fueron mayores en el grupo BEPI ( $p = 0,039$ , IC 95% 1,23-1,42). Se encontró que CEI + BEPI se constituyen en una buena alternativa a CEI +AECP con tasas de satisfacción muy altas en ambos grupos, aunque fue mayor en el grupo BEPI. El grupo BEPI requirió menos bolos de AECP (Rodríguez-Campoó et al., 2019).

La combinación de métodos farmacológicos y no farmacológicos para el alivio del dolor influye de manera significativa en la experiencia del parto de las gestantes atendidas en hospitales de Bagua, Perú. Dentro de las estrategias no farmacológicas, las posiciones maternas durante el trabajo de parto constituyen un elemento relevante para favorecer el confort y disminuir la percepción del dolor.

En un estudio realizado en un hospital público del norte de España, en el que participaron 367 mujeres con parto eutócico atendidas por matronas y residentes de obstetricia durante el año 2018, se evidenció que la mayoría de las gestantes (94,3 %) adoptó posiciones horizontales durante el parto. Asimismo, se identificó limitación en la retroversión sacra en el 71,7 % de los casos, situación que podría estar relacionada con los resultados perineales observados. A pesar de ello, la incidencia de desgarros fue baja, reflejando un adecuado manejo de la fase expulsiva. La tasa de episiotomía alcanzó el 15,3 %, porcentaje ligeramente superior al estándar recomendado.

El estudio también identificó que la primiparidad y la edad materna estuvieron asociadas con un mayor riesgo de episiotomía. De igual manera, se encontró que la movilidad sacra y el uso de posiciones verticales durante el trabajo de parto se relacionaron con una menor frecuencia de lesiones perineales, aportando beneficios tanto para la madre como para el recién nacido. Además, la relación observada entre las posiciones maternas y el uso de analgesia epidural resalta la importancia de considerar estos aspectos dentro del manejo integral del dolor. En conjunto, los hallazgos respaldan la necesidad de promover una atención centrada en la mujer, respetando su autonomía y favoreciendo una experiencia de parto más humanizada (Martín-Vázquez et al., 2024).

En los resultados las participantes afirmaron que las prácticas influyen en la experiencia laboral y en la experiencia del parto vaginal además afectan a la experiencia del parto por cesárea y la experiencia emocional durante el trabajo de parto y el nacimiento (Tavares et al., 2024). Sin embargo, se necesita más investigación para explorar los parámetros biomecánicos y mejorar las experiencias del parto, pero también es importante realizar estudios cualitativos donde las mujeres pudieran evidenciar sus vivencias y/o experiencias respecto al trabajo de parto y parto natural o cesárea y a partir de allí revisar y mejorar las normas nacionales y regionales con un enfoque de interculturalidad.

Las intervenciones farmacológicas, como la analgesia epidural, junto con el apoyo emocional y las técnicas no farmacológicas, ofrecen un manejo completo y respetuoso del dolor, mejorando tanto el bienestar físico como emocional de la paciente.

La aromaterapia y el empleo de aceites esenciales constituyen alternativas no farmacológicas que pueden utilizarse durante el trabajo de parto para contribuir al alivio del dolor y disminuir la ansiedad en la gestante. Estas intervenciones se caracterizan por

ser accesibles, poco invasivas y con escasa probabilidad de efectos adversos, además de poder ser aplicadas por el profesional de enfermería como parte del cuidado integral de la mujer durante el parto (Fonseca et al., 2023).

Si bien el parto natural representa un proceso fisiológico que puede generar dolor intenso, también ofrece importantes beneficios maternos y neonatales. En este contexto, la incorporación de estrategias orientadas a humanizar la atención favorece la relajación de la parturienta, disminuye la tensión emocional y puede contribuir a una evolución más favorable del trabajo de parto, tanto en la fase latente como en la activa, promoviendo además una experiencia positiva y satisfactoria para la mujer (Barbosa et al., 2023).

En relación con ello, un estudio cuasi experimental desarrollado entre mayo y julio de 2018 en un hospital de referencia para partos de bajo riesgo en la región sur de Brasil evaluó el efecto de la terapia floral sobre la evolución del trabajo de parto y sobre variables asociadas al dolor, ansiedad y estrés materno. La investigación incluyó a 60 gestantes, distribuidas en un grupo control y un grupo experimental. La intervención consistió en la administración de esencias florales de Bach durante el trabajo de parto, formuladas para favorecer el equilibrio emocional frente a situaciones de dolor y tensión. Por su parte, el grupo placebo recibió una solución similar sin el componente terapéutico floral.

Los resultados evidenciaron diferencias favorables en el grupo que recibió la terapia floral, observándose mejor evolución en aspectos como la dilatación cervical, las contracciones uterinas, los niveles hormonales relacionados con el estrés y la duración del parto. Asimismo, se concluyó que esta terapia podría representar una alternativa complementaria para favorecer el progreso del trabajo de parto sin generar efectos perjudiciales en el recién nacido. Este caso también aborda el tema de mejorar los conocimientos de las mujeres en el trabajo de parto. Para fortalecer el conocimiento de los especialistas en cuidado de la mujer para guiar la toma de decisiones para las mujeres en el parto (Kassim et al., 2023).

El cuidado especializado de enfermería a una mujer durante el parto es esencial para asegurar un efectivo, seguro y humanizado alivio del dolor. Facilita el seguimiento constante de la madre y el feto, previniendo complicaciones asociadas a la analgesia. Este cuidado potencia el rol de enfermería en equipos interdisciplinarios, promoviendo el parto humanizado. Su meta es garantizar el bienestar físico y emocional de la embarazada, optimizar los resultados perinatales y proporcionar acompañamiento profesional durante

todo el proceso. Por último, las decisiones deben ser siempre personalizadas y basadas en la autonomía de la mujer, constituyéndose en una experiencia gratificante y respetuosa para ella, siguiendo las guías clínicas y las recomendaciones internacionales/nacionales, adaptadas a la realidad constituyéndose trascendental en la vida de las mujeres hospitalizadas en las diferentes instituciones de salud.

## **CONCLUSIONES:**

A partir de la identificación de los diagnósticos de enfermería relevantes para el caso clínico de la gestante G.D.C., se elaboró un plan de cuidados de enfermería que abordó de manera eficaz el manejo del dolor, el control de la ansiedad y la educación sobre el proceso de parto. Las intervenciones planificadas se centraron en el respeto por la autonomía de la mujer, el acompañamiento continuo, el uso de analgesia de forma segura y la enseñanza de técnicas no farmacológicas.

Como resultado, se logró un alivio efectivo del dolor, reducción de la ansiedad y una mayor participación de la paciente en su experiencia de parto. El cuidado brindado se alineó con los principios de atención obstétrica humanizada y basada en evidencia, promoviendo así una experiencia positiva para la madre y el bienestar fetal.

La organización y realización de cuidados personalizados por el equipo de enfermería tuvieron un impacto positivo en el manejo del dolor y en la experiencia gratificante del parto. Este caso pone de manifiesto la relevancia del criterio clínico y la reacción adecuada, habilidades fundamentales en la especialidad de enfermería en situaciones de emergencia y urgencias. La adopción de métodos humanizados y resolutivos facilita la mejora de la atención a la madre, incluso en situaciones de segundo nivel.



## REFERENCIAS:

- Barbosa, J. M., Salazar, N. P., & Souza, A. L. D. M. de. (2023). Perspectiva de enfermeiras obstetras: Utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor do parto. *Rev. Enferm. Atenção Saúde*, 202372-202372.
- Barroga, E., Matanguihan, G. J., Furuta, A., Arima, M., Tsuchiya, S., Kawahara, C., Takamiya, Y., & Izumi, M. (2023). Conducting and Writing Quantitative and Qualitative Research. *Journal of Korean Medical Science*, 38(37), e291. <https://doi.org/10.3346/jkms.2023.38.e291>
- Butcher, H.K., Bulechek, G.M., Dochterman, J.M., & Wagner, C.M. (2018). *Butcher. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC)*. <https://tienda.elsevier.es/clasificacion-de-intervenciones-de-enfermeria-nic-9788413826936.html>
- Chen, N. L., Smyth, H., Sng, B., & Hughes, D. G. (2024). Non-neuraxial labour analgesia. *Best practice & research. Clinical anaesthesiology*, 38 3, 176-186. <https://doi.org/10.1016/j.bpa.2024.04.007>
- Djillali, A., Renault, A., Brun-Buisson, C., Megarbane, B., & Jean-Pierre, Q., Shidas, S. (2018). *Djillali* [Recuperado 10 de enero de 202.]. Beyond Maslow's Pyramid: Introducing a Typology of Thirteen Fundamental Needs for Human-Centered Design. <https://www.mdpi.com/2414-4088/4/3/38>
- Fonseca, M. B., Mata, J. A. L. da, Rocha, C. M. F., & Sanfelice, C. F. de O. (2023). Benefícios do uso de óleos essenciais e da aromaterapia no trabalho de parto. *Rev. Enferm. UFPE on Line*, [1-19].
- García, A. M., & Herranz, V. P. (2023). Métodos no farmacológicos como medida efectiva en el control del dolor en el parto eutócico. *Metas de Enfermería*. <https://doi.org/10.35667/metasenf.2023.26.1003082194>

- Heather, T., K., S. (2021, 2023). *Heather* [ES Elsevier Health.]. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación. <https://tienda.elsevier.es/diagnosticos-enfermeros-definiciones-y-clasificacion-2021-2023-9788413821276.html>
- Huang, J., Zang, Y., Lu, H., & Hu, Y. (2021). Efficacy and safety of non-pharmacological interventions for labour pain management: A systematic review and Bayesian network meta-analysis. *Journal of clinical nursing*. <https://doi.org/10.1111/jocn.15865>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2022). <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-378-de-los-nacimientos-registrados-se-dieron-mediante-cesarea-en-el-ano-2023-15173/>
- Kassim, M. A. K., Brezeanu, D., Brezeanu, A.-M., Helmi, Z. R., Pantazi, A. C., Penciu, R.-C., Nori, W., & Șerbănescu, L. (2023). Non-Pharmacological Pain Management in Labor: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12. <https://doi.org/10.3390/jcm12237203>
- Martín-Vázquez, C., Goás-Gómez, N., Calvo-Ayuso, N., Rosón-Matilla, L., Quiroga-Sánchez, E., & García-Fernández, R. (2024). Analysis of Maternal Positions during the Dilation and Expulsive Phase and Their Relationship with Perineal Injuries in Eutocic Deliveries Attended by Midwives. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 12(4), 441. <https://doi.org/10.3390/healthcare12040441>
- Moorhead, S., Swanson, E. ., Johnson, M. ., Maas, M. L. (2018). *Moorhead* [ES Elsevier Health.]. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). <https://tienda.elsevier.es/clasificacion-de-resultados-de-enfermeria-noc-9788413826714.html>
- Ramos-Matos CF, Bistas KG, Lopez-Ojeda W. Fentanyl. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 [citado 18 dic 2025]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459275/>

- Rodríguez González, I. P., Espinosa Domínguez, E., Quesada García, C., Rodríguez Chimeno, Á., & Borges, R. (2019). Comparison between different epidural analgesia modalities for labor. *Revista Espanola De Anestesiologia Y Reanimacion*, 66(8), 417-424.  
<https://doi.org/10.1016/j.redar.2019.03.004>
- Rodríguez-Campoó, M. B., Curto, A., González, M., & Aldecoa, C. (2019). Patient intermittent epidural boluses (PIEB) plus very low continuous epidural infusion (CEI) versus patient-controlled epidural analgesia (PCEA) plus continuous epidural infusion (CEI) in primiparous labour: A randomized trial. *Journal of Clinical Monitoring and Computing*, 33(5), 879-885.  
<https://doi.org/10.1007/s10877-018-0229-x>
- Sánchez-Migallón, V., Sánchez, E., Raynard, M., Miranda, A., & Borràs, R. M. (2017). Analysis and evaluation of the effectiveness of epidural analgesia and its relationship with eutocic or dystocic delivery. *Revista Espanola De Anestesiologia Y Reanimacion*, 64(7), 369-374.  
<https://doi.org/10.1016/j.redar.2016.10.004>
- Tavares, M., Alexandre-Sousa, P., Victória, A., Loureiro, S., Santos, A. P., & Mendes, J. (2024). Experience of Labour and Childbirth in a Sample of Portuguese Women: A Cross-Sectional Study. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 12(21), 2125.  
<https://doi.org/10.3390/healthcare12212125>
- Vista de cuidado humanizado de enfermería según la teoría de Jean Watson, servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión. Lima-Callao, 2015 [Internet]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2015 [citado 18 dic 2025]. Disponible en: <https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RENH/article/view/3017/2967>
- World Health Organization. (2025). *WHO* (2018.<sup>a</sup> ed.). World Health Organization.  
<https://iris.who.int/handle/10665/260178>

## **ANEXO**

## **CUIDADO HUMANIZADO**

La teoría de Watson J, la Teoría del Cuidado Humano se basa en la armonía entre mente, cuerpo y alma, a través de una relación de ayuda y confianza entre la persona cuidada y el cuidador. Su teoría tiene un enfoque filosófico (existencial-fenomenológico), con base espiritual, cuidado como un ideal moral, y ético de la enfermería. Filosofía De Jean Watson sostiene que el Cuidado Humano comprende; un Compromiso Moral (Proteger y realzar la dignidad humana; va más allá de una evaluación médica), la experiencia, percepción y la conexión: (Mostrando interés profundo a la persona).El cuidado humanizado requiere de un compromiso moral por parte de los profesionales de salud, el cual requiere cada individuo, sea sano o enfermo, para mejorar su calidad de vida, inmerso en la educación en cada cuidado brindado, y de esta manera elevar la percepción de los pacientes en relación al cuidado humanizado.

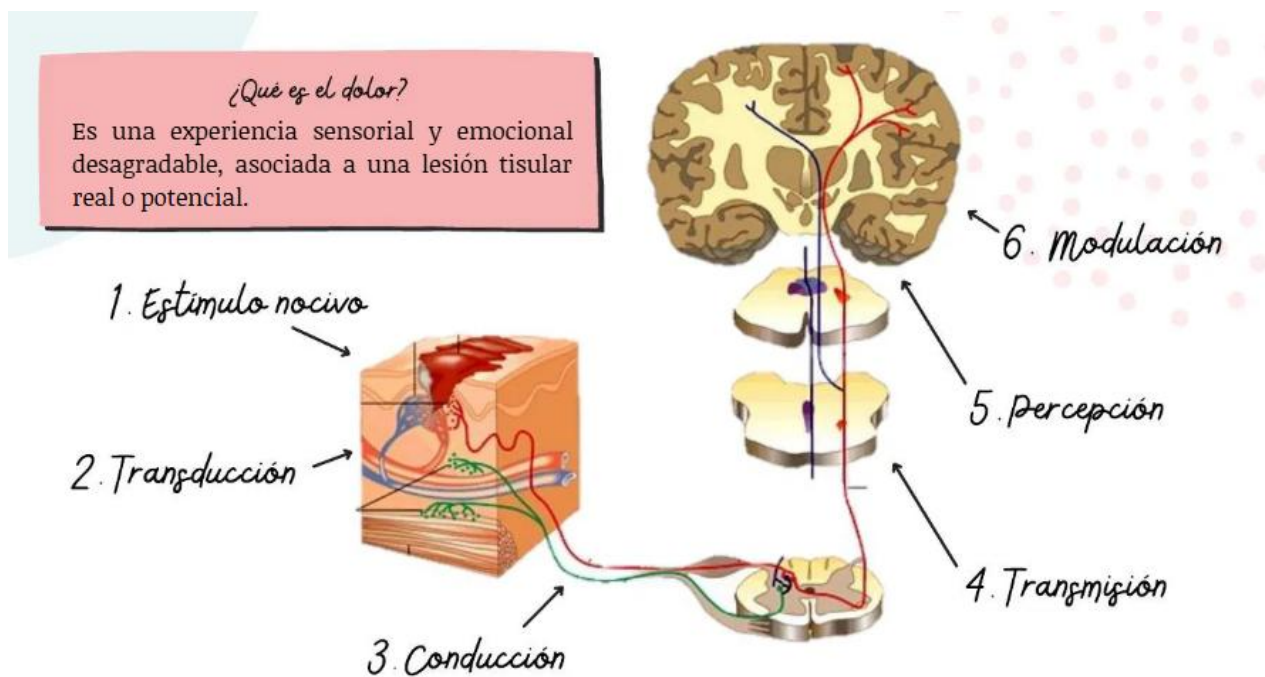
## **MECANISMO DE ACCION DEL FENTANILO**

El fentanilo es similar a otros opioides. Sus moléculas actúan sobre una subclase de sistemas de receptores opioides en el cuerpo, muchos de los cuales se localizan en el cerebro, dentro de estructuras neuroanatómicas especializadas, que involucran particularmente el control de las emociones y el dolor y, en relación con sus infames propiedades adictivas, la recompensa. Bioquímicamente, es un agonista opioide selectivo del receptor Mu. Sin embargo, tiene la capacidad de activar otros receptores del sistema opioide, como los delta y potencialmente los kappa. En consecuencia, la activación de estos receptores, en particular los receptores Mu, produce analgesia. Además, el neurotransmisor dopamina (Da) aumenta en las áreas de recompensa del cerebro, lo que provoca los típicos efectos de euforia y relajación, y se asocia típicamente con la adicción a la droga. [6]

El fentanilo se metaboliza hepáticamente a través del sistema enzimático CYP450,

específicamente CYP3A4. El fármaco tiene una vida media de 3 a 7 horas. Se excreta en un 75 % por orina y un 9 % por heces.

## FISIOPATOLOGIA DEL DOLOR



## VÍA ASCENDENTE

### 1. Estimulo

Los estímulos causantes del dolor se llaman *noxa*s, y son detectados por receptores sensoriales específicos llamados *nociceptores*.



### 2. Transducción

El estímulo se convierte en un potencial de acción.



### 3. Conducción

Se lleva el estímulo eléctrico por los nervios espinales al ganglio de Gasser y de ahí al asta dorsal de la médula espinal.

Esto puede ser de conducción rápida: fibras A $\delta$ , y conducción lenta: fibras C. Ahí se liberan los neurotransmisores: glutamato, noradrenalina, serotonina y sustancia P.



### 4. Transmisión

La información es transmitida desde la médula espinal al tálamo y finalmente a la corteza cerebral (sensitiva).



### 5. Percepción

La corteza sensitiva interpreta la información y genera la respuesta.



## VÍA DESCENDENTE

### 6. Modulación

La activación de este sistema por las endorfinas ocurre a través de receptores específicos: *opioides*. Este se activa alrededor de la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo. Aquí se produce serotonina, norepinefrina y GABA, que generan una neuromodulación.

Los opioides endógenos y exógenos dan lugar a un bloqueo indirecto de los canales de calcio y apertura de los canales de potasio, con hiperpolarización celular e inhibición de la liberación de mediadores del dolor. Esto da lugar a la liberación de  $\delta$ -endorfinas, encefalinas, dinorfinas; que alivian el dolor.

Mariemy Suaste Salazar